

факторов и неблагоприятной экологической обстановки.

Запущенность рака молочной железы остается на прежнем уровне, что свидетельствует о необходимости повышения качества реализуемой скрининговой программы, строгого соответствия принятой в стране лечебно-организационной тактики, вследствие прямой пропорциональности эффективности лечения РМЖ и прогноза от стадии заболевания.

Заболеваемость раком шейки матки в г.Алматы остается стабильно высокой. Снизился удельный вес больных с запущенными стадиями заболевания, одной из причин которой явилось улучшение качества проводимого онкоцитологического скрининга, в том числе оппортунистического.

Своевременное, адекватное лечение больных с фоновыми

и предраковыми заболеваниями шейки матки позволит снизить процент заболеваемости и запущенности РШМ.

Учитывая малосимптомность начальных стадий рака яичников необходимо активное выявление этой патологии – регулярные гинекологические осмотры с применением дополнительных методов исследования – УЗИ органов малого таза в качестве скрининг-метода в группах риска по данному заболеванию. Больные с любыми опухолями яичников, в том числе при безэффективности консервативного лечения, должны подвергаться оперативному лечению с использованием метода экспресс-биопсии.

Динамика онкологической заболеваемости молочной железы по Республике Казахстан

Сактаганов М. И., Абдукаримова Д. Х., Джакипбаева А. К.,

Танжарыков Е. С., Куланбаев Е. М., Сметов С.Б

Городской онкологический диспансер г. Алматы,

Казахский национальный медицинский университет им. Асфендиярова

Одними из самых актуальных вопросов в онкологии являются первичная и вторичная профилактика, ранняя диагностика, усовершенствование методов лечения злокачественных опухолей. Изучение динамики заболеваемости, смертности от злокачественных новообразований необходимо для оценки результатов скрининговых программ и разработки плана мероприятий для их улучшения.

Рак молочной железы (РМЖ), по данным ВОЗ, занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин. В Республике Казахстан в 2010 году РМЖ занял первое место в стране по заболеваемости и смертности в структуре онкозаболеваний женской репродуктивной сферы.

Проведен анализ онкозаболеваемости раком молочной железы по Республике Казахстан и по г.Алматы за период 2005-2010 гг. (Диаграмма 1).

Отмечается некоторое повышение заболеваемости РМЖ в РК с 19,5 до 20,6‰. В г.Алматы заболеваемость РМЖ остается достаточно высокой и стабильной 33,0‰-33,5‰, в последние годы РМЖ в г.Алматы занимает первое место в структуре общей онкологической заболеваемости.

С 2005 по 2010 гг. общая смертность от РМЖ по РК несколько снизилась с 9,1 до 8,7‰, в г.Алматы немного повысилась с 13,0 до 14,2‰.

Важным показателем выполнения скрининговых программ является удельный вес ранних форм РМЖ (диаграмма 2).

В период с 2005 по 2010 гг. по Республике Казахстан и г.Алматы удельный вес ранних форм РМЖ повысился с 61% (59,9%) до 74,1% (74,6%) соответственно.

Удельный вес запущенных форм по РК и г.Алматы несколько снизился с 9,9% (7,2%) до 6,9% (6,1%) соответственно.

В г.Алматы с 2009 года проводится маммографический скрининг женщин декретированного возраста. Данные маммографического скрининга представлены в таблице № 1.

По данным 10 месяцев 2011 г., маммографический скрининг, проводимый в поликлиниках г.Алматы выявил 33

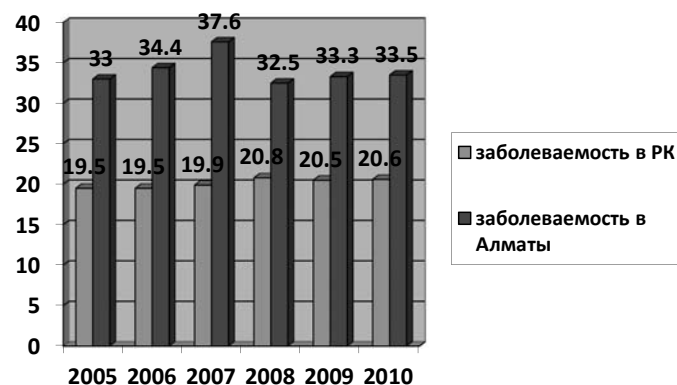


Диаграмма 1. Структура заболеваемости раком молочной железы в РК и в г.Алматы за 2005-2010 гг.

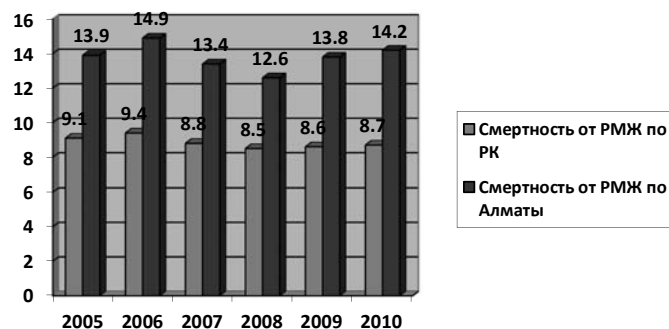


Диаграмма 2. Структура смертности от рака молочной железы в РК и в г.Алматы за 2005-2010 гг.

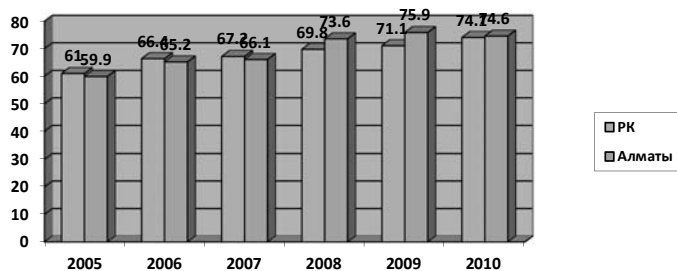


Диаграмма 3. Динамика удельного веса ранних форм рака молочной железы в РК и г.Алматы за 2005-2010 гг. (%)

Годы	Обследовано женщин маммографически	Из них выявлен РМЖ по маммографии
2009	43834	79
2010	42367	16
2011	38067	33

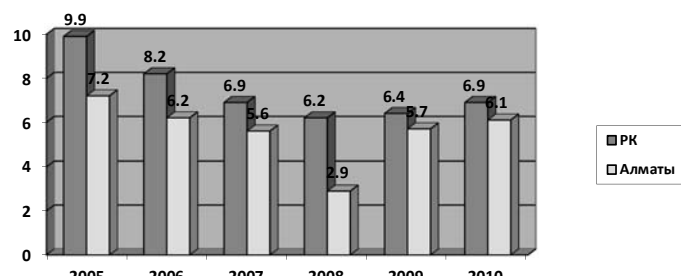


Диаграмма 4. Динамика удельного веса запущенных форм рака молочной железы в РК и г.Алматы за 2005-2010 г. (%)

женщины со злокачественной опухолью молочной железы, из них: с I стадией – 7 (21%), со IIa – 18 (55%), со IIb – 4

(12%), с III – 4 (12%), с IV – 0, т.е. удельный вес ранних форм составил 76%.

Выводы

Заболеваемость РМЖ в РК остается по-прежнему высокой (19,5- 20,6‰), находится на 1 месте в структуре онкологической заболеваемости у женщин. В г.Алматы заболеваемость по РМЖ остается одной из самых высоких в РК (33‰-33,5‰), занимает 1-е место в структуре общей онкологической заболеваемости.

Применение маммографического скрининга способствует повышению удельного веса ранних форм РМЖ, что несомненно приведет к повышению эффективности лечения РМЖ и улучшению прогноза заболевания.

Полимодальное лечение послеоперационной боли

Денисенко Э.В.

Отделение анестезиологии и реанимации онкодиспансера г. Алматы

В настоящее время одной из актуальных проблем послеоперационного периода остается поиск более эффективных методов обезболивания.

Операционная травма и сопровождающая её боль является пусковым механизмом стресс-реакции. Будучи мощным стимулятором вегетативной нервной системы, боль опосредованно оказывает отрицательное воздействие на функции различных органов и систем. Напряжение функций этих систем, прежде всего кровообращения и дыхания, проявляется повышением давления, тахикардией, нарушением сердечного ритма, учащением дыхания и т. д. Конечным звеном этих реакций является нарушение периферического кровообращения, которое может перечеркнуть весь труд хирурга.

К другим клиническим проявлениям стресс-реакции относятся снижение двигательной активности, «вынужденное» положение тела, неспособность откашливать мокроту и глубоко дышать.

Наконец, неэффективное обезболивание в первые сутки послеоперационного периода, возможно, служит одной из причин формирования впоследствии хронического болевого синдрома (ХБС), который может сохраняться у пациентов длительное время.

Углубленное изучение патофизиологии послеоперационного периода привело к тому, что первоначальная вера в адаптационную мудрость организма, когда его стресс-реакция на травму рассматривалась как необходимый для выживания компенсаторный механизм, сменилась осознанием необходимости максимального подавления стресс-ответа. Отсюда следует вывод, что адекватная анальгезия может и должна улучшить исход хирургического лечения.

Классический метод обезболивания наркотиками блокирует центральные механизмы болевого синдрома, но не устраняет причину, имея массу нежелательных побочных эффектов. Последние десятилетия всё больше внимания обращается на изучение периферических механизмов возникновения боли и способы её устранения. Современное представление о механизмах возникновения болевого синдрома и последствиях для организма в целом следующее: при обширной травме тканей медиаторы, выделяющиеся в месте повреждения (серотонин, цитокины, лейкотриены, простагландины), стимулируют полимодальные ноцицепторы, которые вновь усиливают выделение медиаторов, снижая таким образом порог болевой чувствительности (первичная гипералгезия). Местный отек тканей вследствие нарушения проницаемости капилляров под воздействием гистамина, брадикинина еще более сенситизирует рецепторы (вторичная гипералгезия).

В настоящее время одной из актуальных проблем послеоперационного периода остается поиск более эффективных методов обезболивания.

На практике применен метод полимодального послеоперационного обезболивания, что в условиях онкологического диспансера г.Алматы позволило уменьшить расход наркотических анальгетиков и улучшить результаты лечения онкобольных.

Локальный воспалительный процесс является причиной формирования системного ответа на повреждение, что проявляется увеличением концентрации белков острой фазы (С – реактивный белок, фибриноген, плазменный альбумин). Затем происходит активация ряда медиаторных систем (кининовая, системы комплемента, липидных медиаторов и цитокинов).

Таким образом, выраженный воспалительный ответ для организма в большей степени является разрушительным, нежели защитным. Первые двое суток послеоперационного периода являются определяющими для прогноза исхода хирургического лечения и предъявляют особые требования к выбору метода и качеству послеоперационного обезболивания.

Исходя из этого представления о периферическом механизме боли, формируются и современные схемы профилактики и лечения послеоперационного болевого синдрома. Патогенетически оправдано использование анальгетиков периферического действия из ряда нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), ингибирующих медиаторы боли и модуляторы воспаления. Доказана и эффективность препаратов типа контрикала – ингибитора синтеза брадикинина.

Хорошо известно и очень важно то, что боль, вызванная хирургическим повреждением тканей, сопровождается спазмом гладкой мускулатуры. Механизм возникновения спазма достаточно сложный, но при рассмотрении патогенеза боли в современной литературе этой взаимосвязи уделяется мало внимания.

Неоспоримо и то, что спазм порождает или усиливает боль. Интересно также то, что связь боли и спазма замыкается на уровне спинного мозга и не контролируется головным мозгом. Образуется замкнутый круг, поддерживающий болевую импульсацию, отягощающую течение послеоперационного периода.

Исходя из этого, становится логичным то, что наркотики не всегда эффективны при спастических болях, мы просто ослабляем восприятие боли за счёт центрального, седативного эффекта, но не устраняет спазм. Эта седация, с одной стороны,